

Discussão técnico-pericial — causalidade epidemiológica, critérios de Bradford Hill e psiquiatria forense

Uso pretendido: base de discussão para pareceres psiquiátrico-forenses, especialmente em temas de nexos causal/concausalidade, dano psíquico, incapacidade laboral e transtornos mentais relacionados ao trabalho.

Texto-base para adaptação. Não substitui a análise individualizada do caso, dos documentos, do exame psíquico, da cronologia clínica e dos elementos probatórios constantes dos autos.

1. Tese central

A contribuição de Rothman e Greenland para a discussão médico-legal consiste em deslocar a análise causal de uma lógica simplificada — causa única, linear, necessária e suficiente — para um modelo probabilístico, multifatorial e interativo de causação. Esse modelo é particularmente relevante em psiquiatria forense, área na qual os desfechos examinados raramente decorrem de um único fator etiológico isolado.

Nos transtornos mentais, a causalidade costuma envolver interação entre vulnerabilidades individuais, história psicopatológica prévia, personalidade, fatores genéticos, eventos de vida, condições sociofamiliares, uso de substâncias, adoecimentos clínicos, exposições ocupacionais, organização do trabalho, experiências traumáticas e fatores de manutenção. Assim, a pergunta pericial não deve ser formulada como se o perito precisasse identificar uma causa exclusiva e autossuficiente, mas sim avaliar se determinado fator, evento ou exposição contribuiu de modo juridicamente e clinicamente relevante para o início, agravamento, manutenção ou recorrência do quadro psíquico.

Esse raciocínio é compatível com a tradição da psiquiatria forense brasileira, especialmente quando os compêndios nacionais enfatizam a necessidade de exame técnico, análise documental, reconstrução cronológica, avaliação do estado mental, consideração da personalidade prévia, estudo da capacidade funcional e prudência na formulação de conclusões periciais.

2. Causas suficientes e causas componentes aplicadas à psiquiatria forense

Rothman e Greenland descrevem a doença como resultado da completude de uma “causa suficiente”, composta por múltiplas causas componentes. Cada componente pode não ser

suficiente isoladamente, mas pode integrar um conjunto causal que, uma vez completo, produz o desfecho.

Essa formulação é especialmente útil em psiquiatria forense. Um episódio depressivo maior, um transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno de adaptação, um quadro ansioso grave, um episódio psicótico ou uma síndrome de burnout não costumam ter uma causa única. Em vez disso, podem resultar da convergência de múltiplos componentes, alguns predisponentes, outros precipitantes e outros perpetuadores.

Em linguagem pericial, isso permite distinguir:

- **fatores predisponentes:** vulnerabilidade pessoal, antecedentes familiares, traços de personalidade, história psiquiátrica anterior, experiências adversas precoces;
- **fatores precipitantes:** evento traumático, assédio moral, acidente, exposição ocupacional crítica, conflito laboral intenso, sobrecarga aguda, ruptura conjugal, luto, processo disciplinar;
- **fatores perpetuadores:** manutenção da exposição, ausência de suporte, litígio prolongado, ganhos secundários, falha terapêutica, comorbidades, retorno a ambiente adverso;
- **fatores agravantes:** intensificação da carga laboral, reexposição ao agente estressor, humilhações reiteradas, isolamento, piora funcional, interrupção de tratamento.

Dessa forma, mesmo que um fator laboral, traumático ou relacional não seja suficiente, isoladamente, para produzir o transtorno mental, ele pode ser causalmente relevante como componente necessário daquele caso concreto ou como concausa de agravamento.

3. Conexão com a tradição brasileira da psiquiatria forense

Os principais compêndios brasileiros de psiquiatria forense — especialmente a tradição representada por **Taborda, Chalub, Abdalla-Filho e Telles**, bem como por **Palomba** e pela literatura médico-legal brasileira — costumam enfatizar que a perícia psiquiátrica não se resume ao diagnóstico nosológico. Ela deve integrar diagnóstico, história clínica, exame psíquico, capacidade funcional, nexos temporal, coerência narrativa, documentação, repercussão jurídica e resposta objetiva aos quesitos.

Nesse sentido, a contribuição de Rothman e Greenland é metodologicamente convergente com a prática pericial brasileira por quatro razões principais:

1. **Afasta o reducionismo monocausal.** A psiquiatria forense brasileira reconhece a complexidade dos transtornos mentais e a necessidade de avaliação individualizada. O modelo de causas componentes reforça que a existência de fatores pessoais ou antecedentes psiquiátricos não exclui, por si só, a relevância causal de evento externo ou exposição ocupacional.
2. **Favorece o raciocínio de concausalidade.** Em perícias trabalhistas, cíveis, previdenciárias e administrativas, a questão frequentemente não é se o trabalho ou o evento foi a única causa, mas se contribuiu de modo relevante para desencadear, agravar ou perpetuar o quadro.

3. **Exige reconstrução cronológica.** A análise de temporalidade, início dos sintomas, evolução, afastamentos, recaídas, tratamentos e reexposições é compatível com a técnica pericial clássica, que valoriza anamnese, documentação e exame longitudinal.

4. **Impõe prudência inferencial.** A ausência de prova absoluta não impede conclusão pericial tecnicamente fundamentada, mas a conclusão deve explicitar o grau de compatibilidade, os elementos favoráveis e contrários, as limitações dos dados e as hipóteses alternativas.

4. Bradford Hill: pontos de vista, não checklist rígido

O artigo clássico de Bradford Hill deve ser interpretado com cautela em psiquiatria forense. Hill não propôs critérios rígidos, absolutos ou cumulativos. Ele falou em “pontos de vista” para orientar o juízo causal diante de uma associação observada.

Rothman e Greenland reforçam essa leitura crítica: os critérios de Hill não são condições necessárias nem suficientes para afirmar causalidade. Sua utilidade está em organizar a discussão, testar hipóteses alternativas e qualificar a força da inferência causal.

Na psiquiatria forense, isso é decisivo. Exigir que todos os critérios estejam presentes para reconhecer nexos psíquicos seria metodologicamente inadequado, pois os transtornos mentais raramente apresentam especificidade etiológica, dose-resposta linear clara ou marcador biológico definitivo. Por outro lado, ignorar completamente esses parâmetros também fragilizaria o parecer. O uso adequado é intermediário: os critérios funcionam como estrutura argumentativa, não como fórmula automática.

5. Aplicação à análise de nexos ocupacional em saúde mental

Em demandas envolvendo transtornos mentais relacionados ao trabalho, a análise causal deve integrar os seguintes eixos:

5.1 Temporalidade

A exposição ocupacional, o evento traumático ou o conflito laboral relevante devem anteceder o início, agravamento ou recidiva dos sintomas. A temporalidade é o elemento mais indispensável da análise causal.

Em psiquiatria forense, não basta afirmar que o trabalho era estressante e que o indivíduo adoeceu. É necessário reconstruir a sequência temporal:

- situação psíquica anterior;
- início da exposição ou evento relevante;
- surgimento dos sintomas;
- procura por atendimento;
- afastamentos;

- resposta ao tratamento;
- eventual melhora com afastamento;
- recaída com retorno ou expectativa de retorno;
- persistência ou remissão após cessação da exposição.

5.2 Plausibilidade clínica e psicopatológica

A hipótese causal deve ser compatível com o conhecimento psiquiátrico sobre estresse crônico, trauma, sobrecarga, humilhação, ameaça, perda de autonomia, privação de sono, demandas excessivas, conflitos hierárquicos, violência psicológica e ruptura da identidade ocupacional.

A plausibilidade não exige marcador biológico específico. Exige coerência entre o tipo de exposição e o tipo de desfecho psíquico observado. Por exemplo, exposição crônica a humilhações, metas inalcançáveis, isolamento e ameaça de demissão pode ser plausivelmente relacionada a sintomas ansioso-depressivos, insônia, hipervigilância, queda de autoestima, ideação de ruína, sintomas somáticos e prejuízo funcional.

5.3 Gradiente de exposição ou intensidade

Em saúde mental, o gradiente biológico raramente aparece como medida quantitativa simples. Pode, contudo, ser avaliado por intensidade, frequência, duração e acúmulo da exposição:

- aumento de jornada;
- intensificação de metas;
- repetição de humilhações;
- exposição prolongada a risco;
- redução de autonomia;
- acúmulo de funções;
- privação de pausas;
- agravamento progressivo dos sintomas durante a exposição;
- melhora parcial em períodos de afastamento.

O gradiente, portanto, pode ser clínico-funcional e longitudinal, não necessariamente laboratorial ou biométrico.

5.4 Reversibilidade ou experimento natural

A melhora clínica durante afastamento do ambiente supostamente nocivo e a piora diante da reexposição ou da iminência de retorno constituem elemento semiológico relevante. Não provam causalidade isoladamente, mas funcionam como “experimento natural” compatível com o raciocínio de Hill.

Em perícias psiquiátricas, esse padrão deve ser analisado com cuidado, pois pode sofrer influência de fatores não específicos, como alívio do litígio, afastamento de demandas gerais, uso de medicação, psicoterapia, apoio familiar ou expectativas subjetivas. Ainda assim, quando

documentado de modo consistente, temporalmente coerente e associado a outros elementos, fortalece a hipótese de nexos ou concausalidade.

5.5 Coerência documental e funcional

A hipótese causal deve ser coerente com documentos médicos, prontuários, relatórios ocupacionais, comunicações internas, testemunhos, evolução terapêutica, exames anteriores, afastamentos previdenciários e achados do exame psíquico. A coerência não significa ausência absoluta de contradições, mas compatibilidade geral entre narrativa, documentação e expressão clínica.

5.6 Exclusão relativa de hipóteses alternativas

Rothman e Greenland enfatizam que inferência causal envolve avaliar explicações concorrentes. Na perícia, isso corresponde a examinar hipóteses alternativas, como:

- transtorno mental anterior independente;
- episódio relacionado a fatores familiares ou conjugais;
- uso de substâncias;
- doença clínica geral;
- luto, trauma extralaboral ou conflito financeiro;
- simulação, agravamento voluntário ou inconsistências relevantes;
- evolução natural de transtorno crônico;
- ganhos secundários ou fatores litigiosos.

A presença de hipóteses alternativas não exclui automaticamente o nexo. O que se deve avaliar é se elas explicam melhor o conjunto dos fatos do que a hipótese de nexo ou concausalidade ocupacional.

6. Implicações para incapacidade laboral

Causalidade e incapacidade são perguntas distintas. Um transtorno mental pode ser causalmente relacionado ao trabalho sem gerar incapacidade atual; inversamente, pode haver incapacidade psiquiátrica sem nexo ocupacional.

A discussão causal deve ser separada da discussão funcional. A avaliação da incapacidade exige examinar:

- diagnóstico atual;
- gravidade dos sintomas;
- prejuízo cognitivo, afetivo, volitivo e relacional;
- riscos associados;
- adesão e resposta ao tratamento;

- exigências da função habitual;
- possibilidade de readaptação;
- prognóstico;
- compatibilidade entre sintomas referidos, exame psíquico e funcionamento observado.

Essa distinção é coerente com a boa prática da psiquiatria forense brasileira, que exige que o perito diferencie diagnóstico, nexos, danos, incapacidade e prognóstico.

7. Implicações para dano psíquico

Em ações cíveis ou trabalhistas, a discussão sobre dano psíquico exige mais do que a presença de sofrimento subjetivo. É necessário verificar se há transtorno mental identificável, alteração funcional relevante, nexo temporal e causal plausível, persistência ou gravidade do quadro, necessidade terapêutica e repercussão na vida civil, laboral, familiar ou social.

O modelo de Rothman e Greenland ajuda a evitar dois erros:

1. **Erro de exclusão indevida:** negar nexo apenas porque havia vulnerabilidade prévia ou múltiplos fatores envolvidos.
2. **Erro de atribuição excessiva:** atribuir todo sofrimento psíquico ao evento investigado sem avaliar causas componentes alternativas e sem demonstrar coerência clínico-documental.

A formulação mais adequada, em muitos casos, é reconhecer eventual papel concausal, agravador ou desencadeante, quando sustentado pela cronologia, pela plausibilidade psicopatológica e pelos elementos documentais.

8. Texto-modelo para discussão em parecer

A análise de nexo causal em psiquiatria forense não pode ser reduzida a uma concepção monocausal e linear. Os transtornos mentais, em regra, resultam da interação de múltiplos fatores predisponentes, precipitantes e perpetuadores, motivo pelo qual a presença de vulnerabilidades pessoais, antecedentes clínicos ou fatores extralaborais não exclui, por si só, a possibilidade de participação causal ou concausal de determinado evento ou exposição.

Nesse sentido, o modelo epidemiológico de causas suficientes e causas componentes, descrito por Rothman e Greenland, é particularmente útil à análise médico-legal. Segundo tal modelo, uma causa específica pode não ser necessária nem suficiente, isoladamente, para produzir o desfecho, mas ainda assim integrar o conjunto de condições sem as quais o evento mórbido não teria ocorrido naquele momento, naquela intensidade ou com aquela evolução.

Aplicado à psiquiatria forense, esse raciocínio permite compreender que exposições ocupacionais adversas, eventos traumáticos, assédio moral, sobrecarga persistente, perda de autonomia, conflitos hierárquicos ou reexposição a ambiente percebido como ameaçador podem atuar como componentes causais de desencadeamento, agravamento ou manutenção

de transtornos mentais, desde que haja compatibilidade temporal, plausibilidade psicopatológica, coerência documental e ausência de explicação alternativa mais provável.

Os chamados critérios de Bradford Hill devem ser utilizados, nesse contexto, como pontos de vista orientadores da análise causal, e não como lista rígida ou cumulativa. Temporalidade, plausibilidade, coerência, intensidade da exposição, resposta ao afastamento e piora à reexposição são elementos que, quando convergentes, fortalecem a inferência pericial. Nenhum deles, isoladamente, prova causalidade de modo absoluto; em conjunto, contudo, podem fornecer base técnico-científica suficiente para conclusão de nexos ou concausalidade, conforme o padrão de análise médico-legal aplicável.

Por outro lado, a conclusão pericial deve permanecer prudente e proporcional às evidências disponíveis. A inferência causal deve considerar hipóteses alternativas, antecedentes pessoais, comorbidades, fatores extralaborais, evolução clínica, resposta terapêutica, consistência do relato, documentação contemporânea aos fatos e achados do exame psíquico. Assim, a conclusão não deve afirmar causalidade de forma automática, mas explicitar se o conjunto probatório é mais compatível com ausência de nexos, nexos diretos, concausalidade, agravamento, desencadeamento ou mera coincidência temporal.

9. Formulações úteis para parecer

9.1 Quando houver elementos favoráveis ao nexos/concausalidade

O conjunto dos elementos analisados revela compatibilidade temporal, plausibilidade psicopatológica e coerência clínico-documental entre a exposição descrita e a evolução do quadro psíquico. Considerando a natureza multifatorial dos transtornos mentais, a exposição em análise não precisa ser compreendida como causa única ou exclusiva, mas pode ser tecnicamente considerada componente causal relevante, com papel de desencadeamento, agravamento ou manutenção do quadro, caso confirmados os demais elementos probatórios.

9.2 Quando houver apenas possibilidade, sem segurança suficiente

Embora exista coincidência temporal parcial entre os fatos narrados e a sintomatologia psíquica, os elementos disponíveis não permitem estabelecer, com segurança técnico-pericial, que a exposição investigada tenha atuado como causa ou concausa relevante do quadro. A conclusão permanece limitada pela insuficiência de documentação contemporânea, pela presença de fatores alternativos relevantes e/ou pela ausência de coerência longitudinal suficiente.

9.3 Quando houver antecedentes psiquiátricos

A existência de antecedentes psiquiátricos não exclui, por si só, a possibilidade de nexos ou concausalidade. Do ponto de vista médico-legal, deve-se avaliar se o evento ou exposição investigada produziu agravamento, recidiva, mudança de patamar sintomático, piora funcional

ou necessidade terapêutica adicional em relação ao estado anterior. A análise deve distinguir vulnerabilidade prévia de ausência de causalidade.

9.4 Quando houver melhora no afastamento e piora no retorno

O padrão longitudinal caracterizado por melhora parcial durante afastamento da exposição e reagudização sintomática diante da reexposição ou da iminência de retorno constitui elemento semiológico relevante, compatível com o raciocínio de reversibilidade ou experimento natural. Tal achado, entretanto, deve ser interpretado em conjunto com a documentação clínica, o tratamento instituído, fatores psicossociais concomitantes e hipóteses alternativas.

9.5 Quando a discussão envolver incapacidade

A presença de nexo causal ou concausalidade não equivale, automaticamente, à existência de incapacidade laboral atual. A incapacidade deve ser analisada separadamente, com base na gravidade dos sintomas, no exame do estado mental, na funcionalidade, nas exigências da atividade habitual, no risco ocupacional, na resposta terapêutica e no prognóstico.

10. Referências para sustentação

- Abdalla-Filho E, Chalub M, Telles LEB. **Psiquiatria Forense de Taborda**. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2016.
- Taborda JGV, Chalub M, Abdalla-Filho E. **Psiquiatria Forense**. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2012.
- Palomba GA. **Tratado de Psiquiatria Forense Civil e Penal**. São Paulo: Atheneu; 2003.
- França GV. **Medicina Legal**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. [usar edição disponível]
- Hill AB. The environment and disease: association or causation? **Proc R Soc Med**. 1965;58:295-300.
- Rothman KJ, Greenland S. Causation and causal inference in epidemiology. **Am J Public Health**. 2005;95 Suppl 1:S144-S150. doi:10.2105/AJPH.2004.059204.
- Rothman KJ, Greenland S, Lash TL. **Modern Epidemiology**. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.

11. Nota de prudência para uso em casos concretos

Este texto fornece base metodológica geral. Em caso concreto, a conclusão pericial deve ser individualizada e fundamentada nos elementos específicos dos autos, com separação clara entre relato, documentação, exame clínico, inferência técnica e conclusão médico-legal.